Documento de Requisitos

Projeto: Sistema de Fluxo Hospitalar

Registro de Alterações:

Versão	Responsável	Data	Alterações
0.1	Johnny Reberty Alves Oliveira	06/10/2025	Criação do Documento

1. Introdução

Este documento apresenta os requisitos de usuário da ferramenta Sistema de Fluxo Hospitalar e está organizado da seguinte forma: a seção 2 contém uma descrição do propósito do sistema; a seção 3 contém uma descrição do minimundo apresentando o problema; e a seção 4 apresenta a lista de requisitos de usuário levantados junto ao cliente.

2. Descrição do Propósito do Sistema

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um **Sistema de Triagem Hospitalar** destinado a modernizar e otimizar o processo de atendimento de pacientes no hospital municipal da cidade de **São Paulo do Potengi**. Atualmente, o hospital realiza seus atendimentos de forma manual, exigindo que, a cada nova consulta, seja criada uma ficha física do zero, o que ocasiona lentidão no atendimento, redundância de informações e dificuldade no acompanhamento do histórico clínico dos pacientes.

O sistema proposto visa **centralizar e informatizar o fluxo de triagem hospitalar**, permitindo que todas as etapas — recepção, triagem de enfermagem, atendimento médico e dispensação farmacêutica — sejam integradas em um único registro eletrônico. Dessa forma, cada setor poderá acessar e complementar os dados do paciente de forma sequencial, segura e eficiente, reduzindo o tempo de espera e melhorando a qualidade do atendimento prestado.

Além de informatizar o processo de triagem, o sistema também proporcionará **controle de acesso por perfil profissional**, **acompanhamento do status do paciente em tempo real** e **armazenamento histórico de atendimentos**, garantindo integridade, rastreabilidade e conformidade com as normas de proteção de dados (LGPD).

3. Descrição do Minimundo

O **Hospital Municipal de São Paulo do Potengi** possui um setor de triagem que funciona como a porta de entrada para todos os atendimentos realizados. O processo de atendimento é dividido em **quatro fases distintas**, cada uma executada por profissionais diferentes e interligadas por meio de um único sistema de informação.

Na **Fase 1 – Recepção**, o paciente chega ao hospital e apresenta seu **Cartão SUS** ou **CPF**. O atendente realiza o **cadastro dos dados pessoais e de contato**, criando automaticamente um **registro único** no sistema. Esses dados são persistidos no banco de dados e ficam disponíveis para as etapas seguintes do atendimento.

Na **Fase 2 – Enfermagem**, o paciente é encaminhado à enfermeira responsável, que acessa o mesmo registro e adiciona **informações clínicas iniciais**, como sintomas relatados, sinais vitais e possíveis alergias. Essas informações complementam o cadastro inicial e são utilizadas na avaliação médica posterior.

Na **Fase 3 – Atendimento Médico**, o médico acessa o registro consolidado do paciente e adiciona **informações do exame clínico**, **diagnóstico** e **prescrição médica**. Após o atendimento, o sistema atualiza o status do paciente e armazena o registro como parte do **histórico de atendimentos**, que poderá ser consultado em visitas futuras.

Por fim, na **Fase 4 – Farmácia**, o farmacêutico visualiza as **prescrições médicas associadas** e realiza o **registro da dispensação de medicamentos**. Ao concluir essa etapa, o atendimento é encerrado e o sistema marca o registro como **finalizado**, mantendo todas as informações armazenadas de forma permanente.

O sistema deve permitir o **acompanhamento em tempo real do status de cada paciente**, desde o momento da chegada até a finalização do atendimento, além de disponibilizar funcionalidades de **consulta de histórico, controle de acesso por função, geração de relatórios gerenciais e backup de dados automáticos**.

Com sua implantação, o hospital passará a contar com um processo digital e integrado, eliminando as fichas manuais, garantindo maior **agilidade**, **segurança da informação** e **continuidade no acompanhamento médico dos pacientes**, trazendo benefícios tanto para os profissionais de saúde quanto para a população atendida.

4. Requisitos de Usuário

Tomando por base o contexto do sistema, foram identificados os seguintes requisitos de usuário:

Requisitos Funcionais

Identificador	Descrição	Prioridade	Depende de
RF01	O sistema deve permitir o **cadastro de pacientes** na recepção, incluindo: Cartão SUS, CPF, Endereço, Telefone, Outras informações básicas	Alta	
RF02	O sistema deve criar **um registro único** para cada paciente, armazenando todas as informações coletadas nas diferentes etapas de triagem.	Alta	
RF03	Cada setor deve **acessar e complementar** o mesmo registro do paciente: Recepção: dados pessoais e administrativos; Enfermagem: sintomas e informações iniciais; Médico: exame clínico, diagnóstico e prescrição; Farmacêutico: registro de dispensação e encerramento do atendimento.	Alta	
RF04	O sistema deve **atualizar automaticamente o status** do paciente conforme ele avança nas etapas: Exemplo: "Em recepção → Em triagem de enfermagem → Em atendimento médico → Finalizado".	Alta	RF03
RF05	Deve ser possível **consultar todo o histórico de atendimentos anteriores** de um paciente.	Alta	
RF06	O sistema deve **diferenciar os tipos de usuário** e restringir funcionalidades: Recepcionista; Enfermeira; Médico; Farmacêutico; Administrador	Alta	
RF07	O sistema deve **armazenar permanentemente** todas as informações no banco de dados, permitindo consultas futuras.	Alta	
RF08	O médico deve poder **inserir prescrições** no sistema, visíveis apenas ao setor farmacêutico ou de Infusão.	Alta	RF02, RF03
RF09	O sistema deve gerar **relatórios de atendimentos, triagens e diagnósticos** para fins administrativos e estatísticos.	Médio	RF02, RF05

Regras de Negócio

Identificador	Descrição	Prioridade	Depende de
RN01	Cada paciente deve possuir **apenas um registro ativo por atendimento**. Caso o paciente retorne posteriormente, deve ser **reativado um novo atendimento vinculado ao seu cadastro existente**.	Alta	
RN02	O fluxo deve respeitar a ordem: **Recepção → Enfermagem → Médico → Farmácia.** Nenhum setor pode acessar o paciente **antes que a etapa anterior esteja concluída,** exceto em casos de urgência médica**.**	Alta	
RN03	O sistema deve atualizar automaticamente o **status** conforme a fase: "Aguardando Recepção" "Em Triagem de Enfermagem" "Em Atendimento Médico" "Aguardando Farmácia" "Atendimento Finalizado"	Alta	
RN04	Acesso restrito por perfil profissional: Recepcionista: pode cadastrar e editar apenas dados pessoais. Enfermeiro(a): pode editar apenas dados clínicos de triagem. Médico(a): pode registrar diagnóstico e prescrição. Farmacêutico(a): pode visualizar prescrição e encerrar atendimento. Administrador: pode gerenciar usuários, relatórios e configurações.	Alta	
RN05	Cada módulo deve conter campos obrigatórios antes de prosseguir para a próxima fase. Exemplo: Recepção: CPF ou Cartão SUS obrigatório. Enfermagem: pelo menos um sintoma registrado. Médico: diagnóstico obrigatório para gerar prescrição.	Alta	
RN06	Após finalizado o atendimento, o registro não pode mais ser alterado, apenas consultado. Alterações posteriores devem gerar um novo atendimento vinculado ao paciente.	Alta	
RN07	Cada alteração no registro deve ser **vinculada ao usuário logado** (recepcionista,	Alta	

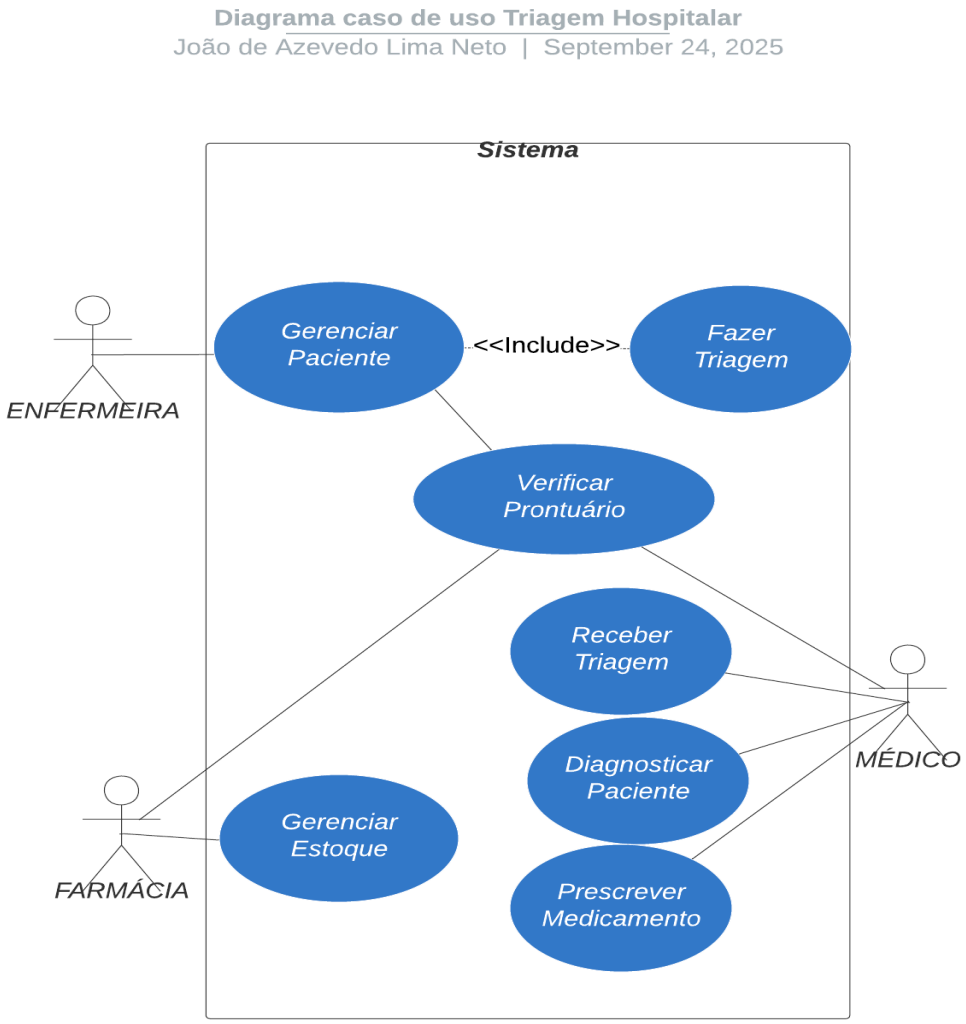
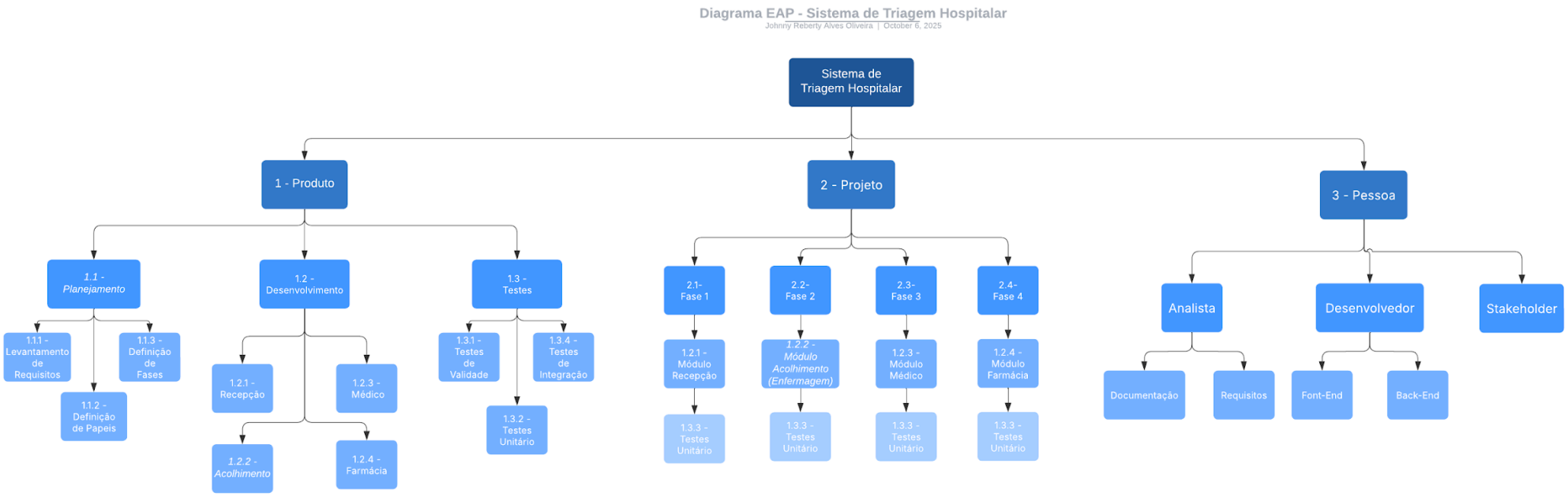
	enfermeira, médico, farmacêutico) com **data e hora da ação**.		
RN08	Somente **médicos autenticados** podem registrar prescrições, e estas devem estar **associadas a um atendimento válido e ativo**.	Alta	
RN09	A farmácia só pode liberar medicamentos se: houver prescrição médica válida; o medicamento constar no estoque do hospital; a dispensação for registrada e confirmada pelo farmacêutico.	Alta	
RN10	Todos os registros devem ser mantidos por, no mínimo, **5 anos**, conforme padrões hospitalares e legislações municipais e federais.	Alta	
RN11	Nenhum usuário pode excluir pacientes ou atendimentos — apenas **marcar como inativo**.	Alta	
RN12	O sistema deve gerar **relatórios e códigos compatíveis com o Sistema Único de Saúde**, possibilitando integração futura com bancos de dados públicos.	Alta	

Requisitos Não Funcionais

Identificador	Descrição	Categoria	Escopo	Prioridade	Depende de
RNF01	A interface deve ser simples, intuitiva e responsiva, adequada ao ambiente hospitalar, com fácil navegação entre módulos.	Portabilidade	Sistema	Alta	
RNF02	O sistema deve responder às ações do usuário em menos de 3 segundos em condições normais de operação.	Agilidade	Sistema	Alta	
RNF03	Acesso deve ser controlado por autenticação (login e senha). Dados sensíveis (como CPF e diagnósticos) devem ser armazenados criptografados. Deve haver controle de permissões por perfil.	Segurança de Acesso	Sistema	Alta	
RNF04	O sistema deve garantir **integridade dos dados**, mesmo em caso de falha de energia ou conexão.	Integridade	Sistema	Alta	
RNF05	O sistema deve estar **disponível 24 horas por dia**, com períodos mínimos de manutenção.	Disponibilidade	Sistema	Alta	
RNF06	O sistema deve ser **acessível via navegador web** em computadores e tablets, sem dependência de instalação local.	Disponibilidade	Sistema	Alta	
RNF07	O código deve ser **modular e documentado**, facilitando futuras atualizações ou correções.	Disponibilidade	Document	Alta	

			ação/Sistema		
RNF08	Deve haver **rotinas automáticas de backup** diárias para evitar perda de informações.	Integridade de dados	Servidor	Alta	
RNF09	O sistema deve seguir as normas de **proteção de dados pessoais (LGPD)** e padrões do **SUS**.		Sistema	Alta	

5. Modelo de Casos de Uso



6. Diagrama EAP